

Prolapso de cordón

1. Introducción y relevancia clínica

El **prolapso del cordón umbilical** es una **emergencia obstétrica aguda** en la cual el cordón **desciende por delante de la presentación fetal**, pudiendo **quedar comprimido entre el feto y las paredes uterinas o el canal del parto**.

Esta compresión **interrumpe el flujo sanguíneo fetal**, generando **hipoxia, bradicardia y muerte fetal en minutos** si no se actúa rápidamente.

Se presenta en aproximadamente **0,1–0,6% de los partos**, pero la **mortalidad perinatal** puede alcanzar el **50% si el parto no se resuelve en menos de 30 minutos**.

□ Pregunta EUNACOM clásica:

“Durante el trabajo de parto, se observa bradicardia fetal brusca y al tacto vaginal se palpa cordón pulsátil antes de la presentación. Diagnóstico: prolapso de cordón. Conducta inmediata: elevar presentación y trasladar a cesárea de urgencia.”

2. Definiciones y clasificación

Tipo de evento	Descripción	Diagnóstico
Procúbito de cordón	El cordón pasa por delante de la presentación pero con membranas íntegras.	Se puede palpar entre membranas y presentación.
Prolapso de cordón	El cordón se exterioriza o descende por el cuello uterino con membranas rotas.	Cordón palpable o visible en vagina o vulva.
Prolapso oculto	El cordón queda comprimido junto al feto, sin protruir.	Solo se sospecha por sufrimiento fetal agudo.

□ En práctica clínica y examen EUNACOM, “prolapso de cordón” generalmente se refiere al caso con membranas rotas y cordón palpable o visible.

3. Fisiopatología

El cordón, al quedar **por delante de la presentación**, sufre **compresión mecánica** con cada contracción o descenso fetal.

Esto genera:

- **Obstrucción del flujo venoso** → congestión y edema del cordón.
 - **Luego compresión arterial** → hipoxia y acidosis fetal.
 - En minutos, puede sobrevenir **muerte fetal intrauterina** si no se alivia la presión.
-

4. Factores de riesgo

Categoría	Ejemplos
Presentación fetal anómala	Podálica, transversa, cara o frente.
Altura elevada de la presentación	Cabeza no encajada, prematuridad.
Cordón largo	>75 cm.
Placenta previa marginal / inserción baja.	Espacio libre entre cabeza y cérvix.
Polihidroamnios	Movilidad excesiva del feto.
Gestación múltiple.	Mayor riesgo por cambios de posición fetal.

Ruptura artificial prematura de membranas con cabeza no encajada. Causa iatrogénica frecuente.

□ EUNACOM: si el caso menciona *amniorrexis artificial con presentación alta y bradicardia fetal*, pensar de inmediato en **prolapso de cordón**.

5. Manifestaciones clínicas

Sospecha

- **Bradicardia fetal sostenida** o desaceleraciones variables repetidas en monitoreo fetal.
- Antecedente de ruptura de membranas reciente.
- Presentación alta o irregular.

Confirmación

- **Tacto vaginal:** palpación de cordón umbilical pulsátil.
- **Visualización:** cordón azul violáceo protruyendo por vulva o vagina.

□ Si el cordón es palpable pero sin pulso → **sufrimiento fetal severo o muerte fetal inminente**.

6. Diagnóstico diferencial

Cuadro	Diferencias clave
Desprendimiento prematuro de placenta (DPPNI)	Hipertonía uterina, dolor, sin cordón palpable.
Ruptura uterina	Dolor súbito, cesárea previa, pérdida de estación fetal.

Bradicardia fetal por fármacos

Temporal, sin evidencia de compresión cordonal.

7. Conducta inmediata (manejo prehospitalario o intraparto)

La vida fetal depende de aliviar la compresión del cordón y resolver el parto lo antes posible.

No hay tiempo para exámenes complementarios.

☐

1. Llamar ayuda y notificar emergencia obstétrica.

☐

2. Mantener al feto fuera de compresión:

- **Posición materna:**
 - **Genupectoral (rodillas-pecho) o Trendelenburg** (cabeza baja).
 - Disminuye presión de la presentación sobre el cordón.
- **Elevar manualmente la presentación fetal:**
 - Introducir mano vaginal para **elevar la cabeza** o presentación hasta que cesárea esté lista.
- **No intentar reintroducir el cordón.**
- **Cubrir cordón visible con gasas estériles humedecidas en suero tibio** (evita vasoespasmo y daño tisular).

☐

3. Suspender contracciones:

- Detener oxitocina.

- Administrar **tocolítico** (ej. **salbutamol 0,25 mg SC o atosibán EV**) si disponible.

☐

4. Oxigenar a la madre

(10–15 L/min).

☐

5. Monitoreo fetal continuo.

☐

6. Preparar para parto inmediato:

- **Cesárea de urgencia:** vía de elección en la mayoría de los casos.
- **Parto vaginal acelerado (fórceps o vacuum)** solo si el feto está coronando y el nacimiento es inminente.

☐ El tiempo ideal desde diagnóstico hasta parto debe ser **<20–30 minutos**.

8. Manejo en casos específicos

Situación	Conducta recomendada
Feto vivo y parto no inminente	Cesárea inmediata.
Feto vivo y parto inminente (coronando)	Parto vaginal rápido asistido.
Feto muerto	Conducta expectante o parto vaginal.

Prolapso oculto

Cesárea si hay sufrimiento fetal no explicado.

9. Prevención

Medida

Recomendación

No realizar amniorrexis artificial con presentación alta o móvil.

Confirmar encajamiento de la cabeza fetal antes de romper membranas.

Monitoreo continuo tras amniorrexis.

Ecografía prenatal si sospecha de cordón procúbito.

☐ La prevención más efectiva: **evitar ruptura de membranas con cabeza no encajada.**

10. Complicaciones

Fetales

- Hipoxia, acidosis metabólica.
- Parálisis cerebral, daño neurológico.
- Muerte intrauterina.

Maternas

- Generalmente secundarias a la urgencia (trauma obstétrico, cesárea urgente, estrés psicológico).
-

11. Pronóstico

- La **sobrevida fetal** depende directamente del tiempo entre prolapso y parto:
 - <10 minutos: sobrevida >90%.
 - 30 minutos: mortalidad >50%.
 - Con detección intrahospitalaria y respuesta inmediata, la sobrevida puede superar el 95%.
-

12. Perlas clínicas y errores comunes en EUNACOM



Perlas

1. Prolapso = cordón **por delante de la presentación** con membranas rotas.
2. Manifestación típica: **bradicardia fetal súbita**.
3. Diagnóstico: **tacto vaginal con cordón pulsátil**.
4. Manejo inmediato: **eleva presentación + posición materna + cesárea urgente**.
5. **No reintroducir el cordón** ni perder tiempo en exámenes.
6. Si parto inminente → **acelerar vaginalmente**.
7. Evitar iatrogenia: **no romper membranas con cabeza alta**.



Errores comunes

- Intentar manipular o devolver el cordón al útero.
 - No interrumpir oxitocina.
 - Demorar cesárea por intentar monitoreo prolongado.
 - No cubrir cordón con gasas húmedas.
 - No colocar madre en posición adecuada.
-

13. Resumen final (5–7 ideas clave)

1. **Prolapso de cordón:** cordón umbilical desciende antes que la presentación → compresión → hipoxia.
2. **Diagnóstico:** bradicardia fetal + cordón palpable o visible.
3. **Medidas urgentes:** elevar presentación, posición materna, oxígeno, suspender contracciones.
4. **Parto inmediato:** cesárea si no está coronando.
5. **Tiempo crítico:** <30 minutos para evitar daño neurológico o muerte fetal.
6. **Nunca reintroducir el cordón.**
7. **Prevención:** confirmar encajamiento antes de amniorrexis.